EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 77338
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 14-01-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EMILIA DEL CARMEN ORELLANA SOTO			RUN	: 7.229.929-9
F.Nac	: 04-06-1953	Edad	: 70 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LA MATA CAMINO TRAPICHE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 87697902		
Fecha Ingreso	: 2024-01-11	Fecha Egreso	: 14-01-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E87.5-HIPERPOTASEMIA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

AKI Prerenal
Obs Gastroenteritis infecciosa
CA recto avanzado en tratamiento paliativo
Ileostomía

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedente de ileostomia desde diciembre por ca recto avanzado. en espera de posible quimio paliativa. Refiere aumento franco en la frecuencia y cantidad de deposiciones por ileostomia de mas de una semana de evolucion, CEG progresivo de varios días.
a su ingreso se constata deshidratada++, K 8.0, creat 1.7
post medidas hiperkalemicas K 5.7, na 118. Destaca leucocitos 21.000 con desviacion izquierda, se comienza ceftriaxona en UE, sin foco pulmonar.

Durante estancia hospitalaria se complementa estudio, además de rescate de exámenes previos los cuales determinan:
RMN De Abdomen Y Pelvis Del 3 De Octubre De 2023: Neoplasia Transmural Del Recto Superior Con Compromiso De La Fascia Mesorrectal Y Reflexión Peritoneal Asociado A Diseminación Linfática, Compromiso Secundario Hepático De La Pared Abdominal Y Carcinomatsis Peritoneal. Posible T4an2m1. Quistes Corticales Bilaterales Uno Bosniak Ii A La Izquierda. Diverticulos De Colon No Complicados.
Colonoscopia Del 10/11/23: Neo De Recto Alto, Colonoscopia Incompleta
1/9/23: Tac De Abdomen Y Pelvis
Lesion Mal Delimitada En El Recto Abdominal Anterior Derecho Con Áreas De Densidad Liquida, Que Se Extiende Al Tejido Adiposo Subcutáneo Y Hacia El Peritoneo. Considerar Origen

Neoplásica Vs Inflamatorio. Lesiones Focales Hepáticas Múltiples, Considerar Origen Secundario. Quiste Renal Simple Izquierdo. Aumento De Calibre De La Biliar Sin Un Factor Obstructivo Evidente, En Paciente Colecistectomizado
Cirugia Oncologica El 01/12/23 Laparoscopia Exploradora.Obstruccion Intestinal, Ileostomia

14-1: Crea 0.7, Glicemia 99, uremia 53, bun 25, Na 130. K 5.1.

11-1 creatinina 1,40, clearence 37,18 uremia 228, sodio 121,00 , potasio 6,40 , orina inflamatoria. lecocitos fecales negativos- Rotavirus Negativo, Clostridium Negativo.

Biopsia De Mucosa De Recto Del 10/11/23: Adenocarcinoma Tubular Invasor Moderadamente Diferenciado G2
Clasificacion Tnm T4

Paciente con aporte hídrico franco evolucionando favorablemente a tratamiento y terapia indicada, con regresión de función renal hacia basal además de regularización de THE. Actualmente con viabilidad de continuar control y seguimiento en domicilio dado que reside con familiares quienes pueden estar a cargo de esta, en un perímetro cercano. En vista de ello, se decide alta médica con HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. DERIVO HODOM
2. Reposo relativo en domicilio
3. Regimen gastroprotector
4. Abundante hidratacion por boca
5. Ceftriaxona 2gr ev (hoy 5/7)
6. Domperidona 10mg vo c8h SOS
7. Control ex lab 48h
8. Control SOS
9. Control AM Oncología HCHM
10. Seguimiento paliativos
11. Control APS 1 semana

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO